

Dane, nie ocena — w czasie rzeczywistym

Pacjent zapisuje w trakcie, nie z pamięci. Nie kalorie — czas, miejsce, kontekst, myśli. Bez tego CBT-E traci >50% skuteczności.

CZAS: 10 min dziennie **REALIZACJA:** od sesji 1 do końca terapii, omawiane na każdej sesji

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, rozdz. 6); Fairburn, Cooper & Shafran (2003); Latner & Wilson (2002); aplikacja *Recovery Record*

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **sześć kolumn dziennika** i co oznaczają kody *B / V / L / E*. Sekcja 02 — **dziewięć zasad prowadzenia**: *real-time*, opisowo (nie kalorie), oznaczenia, kontekst, przegląd, co robić, gdy pacjent nie prowadzi. Sekcja 03 — **wzór dziennika** na dziś.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Dziennik jedzeniowy CBT-E (ang. *self-monitoring record*) — prowadzony codziennie przez cały okres terapii. *Różni się* od „dziennika kalorii” (przeciwwskazany w ED) — zapisujemy *opisowo*: czas, miejsce, jedzenie, kontekst, myśli, kody zachowań (*B, V, L, E*). Zasada *write as you go* — bezpośrednio po jedzeniu, nie z pamięci. Fairburn (2008): bez self-monitorowania CBT-E traci ponad połowę skuteczności. **Dane, nie ocena** — terapeuta nigdy nie „ocenia” dziennika.

01 Sześć kolumn dziennika — co zapisujemy

KOLUMNA	CO TAM WPISAĆ I DLACZEGO
1 · Godzina	Konkretna — np. „8:15”, nie „rano”. Pozwala zobaczyć rytm: czy posiłki są regularne (3+2+1, co 3-4h), czy są przerwy >4h sprzyjające napadom.
2 · Miejsce	Dom, praca, szkoła, restauracja, samochód, łazienka. Miejsce <i>ma znaczenie</i> — np. ukryte jedzenie w łazience to inny wzorzec niż przy rodzinnym stole.
3 · Jedzenie / napój	Opisowo: „2 kromki chleba z serem, kubek kawy z mlekiem”. Nie: „kanapka 200 kcal”. Liczby wzmacniają zaburzenie — opisy budują normalne podejście.
4 · Gwiazdka *	Postaw * przy posiłku zgodnym z planem 3+2+1. Wizualnie pokazuje, ile „strukturalnych” posiłków było danego dnia — łatwo zobaczyć opuszczenia.
5 · Kod B/V/L/E	Na marginesie. <i>B</i> = obiektywny napad, (<i>B</i>) = subiektywny napad, <i>V</i> = wymioty, <i>L</i> = środki przeczyszczające, <i>E</i> = nadmierny ruch kompensacyjny. Daje obraz zachowań kompensacyjnych.
6 · Kontekst / emocje	Krótko — 1 zdanie. „Po kłótni z mamą, byłam/-am zły/-a” lub „Spokojnie, po południowej kawie”. To pokazuje wyzwalacze.

Bez liczb, bez wagi. Dziennik nigdy nie zawiera kalorii, gramów ani aktualnej wagi. Jeśli pacjent „domaga się” liczenia — to objaw nadwartościowania kontroli, nie potrzeba terapeutyczna. Trzymamy opisową formę.



1. **Najważniejsze narzędzie terapii** — przedstawił tak: „To NAWAŻNIEJSZE narzędzie naszej pracy. Bez niego trudno nam pracować. Nie o kalorie — o wzorce”. Bez monitorowania CBT-E traci >50% skuteczności (Fairburn, 2008).
2. **Forma** — tabela z 6 kolumnami (godzina, miejsce, jedzenie, *, kod, kontekst). Kartka A4 dzienna lub aplikacja (*Recovery Record* — zaprojektowana w oparciu o zasady CBT-E).
3. **Zasada write as you go** — pacjent zapisuje *bezpośrednio po* jedzeniu (lub przed/w trakcie), *nie* na koniec dnia z pamięci. Zapis retrospektywny = deformacja przez selektywną pamięć AN.
4. **Bez liczb** — opisowo, nigdy kalorie, makroskładniki ani gramy. „2 kromki chleba z serem, kubek kawy z mlekiem”, nie „kanapka 200 kcal”. Liczby wzmacniają zaburzenie.
5. **Oznaczaj zachowania** — B, (B), V, L, E na marginesie. Daje wizualnie czytelny obraz kompensacji.
6. **Kontekst emocjonalny — krótko** — „co się działo przed jedzeniem? Jak się czułem/-am?” Jedno zdanie wystarczy. Cel: zobaczyć wyzwalacze napadów i restrykcji.
7. **Przegląd na każdej sesji** — pacjent przynosi dziennik. Razem analizujecie: „Jakie wzorce widzisz? Kiedy najmniej jesz? Kiedy napady? Co je poprzedza?” To są dane do interwencji.
8. **Co robić, gdy pacjent nie prowadzi** — to częste. Nie karć. Pytaj: „Co przeszkodziło? Czy było za trudne?” Typowe przyczyny: strach przed konfrontacją ze swoim jedzeniem, brak czasu, „nie wiem co pisać”. Rozwiązuj razem — czasem pomaga uproszczona wersja (5 kolumn zamiast 6) lub aplikacja zamiast papieru.
9. **Nigdy jako kara** — nie „oceniam” dziennika („za mało jadłś”). Dziennik to dane, nie dowód na „złe zachowanie”. Jeśli pacjent czuje, że to ocena — przestanie prowadzić, a terapia traci podstawę.

03 Wzór dziennika — na dzisiaj

[illegible]

Legenda kodów: * = posiłek zgodny z planem 3+2+1; B = obiektywny napad objadania; (B) = subiektywny napad; V = wymioty; L = środki przeczyszczające; E = nadmierny ruch kompensacyjny.

Klucz: dziennik jedzeniowy CBT-E *nie jest* „dziennikiem kalorii” — to narzędzie monitorowania wzorców. *Bez liczb, bez wagi.* U bardzo restrykcyjnych pacjentów z AN dziennik *sam w sobie* bywa przeszkodą — pisanie o jedzeniu paradoksalnie zwiększa obsesję. *Adaptacja:* minimalny dziennik (tylko godzina + ogólny opis + *) przez pierwsze 2 tygodnie, rozszerzanie stopniowe. *Lepszy minimalny dziennik niż żaden.* **Komunikat dla pacjenta:** „*nie oceniamy dziennika. Zbieramy dane, żeby zobaczyć, gdzie mogę Cię wesprzeć. Nie wstydź się tego, co tam napiszesz — to materiał do pracy, nie test*”.

△ **Czerwona flaga:** jeśli pacjent domaga się liczenia kalorii w dzienniku („jak ja mam wiedzieć, czy dobrze jem, bez liczb?”) — nie ustępuj. To jest objaw nadwartościowania kontroli, nie deficyt informacyjny. Trzymamy opisową formę i równolegle pracujemy nad samym przekonaniem („liczby dają mi pewność”) w sekcji nadwartościowania.